ELECTROMAPAS FISIOTERAPIA · KIT PRONTO A USAR NA CONSULTA

KIT DE COMUNICAÇÃO & RETENÇÃO DO UTENTE

O que dizer, o que entregar e o que enviar — da primeira consulta à alta, com linguagem clara para o utente e respeito pelo RGPD

O QUE ENCONTRAS NESTE KIT:

- ✓ **Explicar eletroterapia em 30 segundos**
  Falas prontas para TENS, NMES, FES e Interferencial.
- ✓ **Responder a medos e objeções**
  «Vai dar choque?», «Dói?», «Tenho pacemaker» e mais 6.
- ✓ **Consentimento informado preenchível**
  Modelo com campos editáveis no PDF ou para imprimir.
- ✓ **Folheto e plano domiciliário**
  «O que vai sentir na sessão» + plano de exercícios para preencher.
- ✓ **10 mensagens WhatsApp/SMS + Google**
  Follow-up, reativação e avaliações — só com consentimento.

Autor: Jel Vitor — Coleção Oficial ElectroMapas Fisioterapia

Edição digital · 15 páginas · Consulta no telemóvel, tablet ou impressão

Material educativo de apoio · não substitui avaliação nem julgamento clínico

Índice e como usar este kit

pág. 3	Explicar a eletroterapia em 30 segundos — TENS e NMES
pág. 4	Explicar a eletroterapia em 30 segundos — FES e Interferencial + regras de linguagem
pág. 5–6	Medos e objeções do utente: respostas prontas
pág. 7–8	Modelo de consentimento informado para eletroterapia (preenchível)
pág. 9	Folheto para o utente: «O que vai sentir na sessão»
pág. 10	Plano domiciliário modelo
pág. 11–12	10 mensagens de follow-up e reativação (WhatsApp/SMS)
pág. 13	RGPD na prática + registo de consentimentos de contacto
pág. 14	Guião para pedir avaliações no Google (e responder-lhes)
pág. 15	Checklist da primeira consulta

Como usar

- As falas são pontos de partida: lê-as em voz alta duas ou três vezes e adapta-as à tua maneira de falar. O utente nota quando estás a recitar.
- Texto entre parênteses retos — [nome], [data], [gabinete] — é para substituir pelos dados reais antes de usar.
- Os campos do consentimento informado (págs. 7–8) e do plano domiciliário (pág. 10) podem ser preenchidos diretamente no PDF (Adobe Acrobat Reader ou equivalente) ou impressos e preenchidos à mão.
- As páginas 9 e 10 foram pensadas para imprimir e entregar ao utente.

NOTA IMPORTANTE

Este kit é material de apoio à comunicação. Os modelos de consentimento, mensagens e registos são orientativos: adapta-os às normas da tua instituição, ao código deontológico aplicável e à legislação em vigor (incluindo o RGPD). Não constitui aconselhamento jurídico.

© Todos os direitos reservados

Explicar a eletroterapia em 30 segundos (1/2)

Estrutura de cada fala: o que é → o que vai sentir → para que serve → o utente tem o controlo.

TENS — alívio da dor

«Vou colocar uns elétrodos à volta da zona da dor, ligados a este aparelho, que envia impulsos elétricos muito fracos. Vai sentir um formigueiro, como pequenas agulhinhas, mas não deve doer. Esse formigueiro ajuda a baralhar a mensagem de dor que segue para o cérebro e, normalmente, a dor baixa durante e logo a seguir. Vamos aproveitar esse alívio para fazer os exercícios com menos dor. Se em algum momento ficar desconfortável, diga-me e eu ajusto logo.»

Porque funciona: antecipa a sensação (reduz a ansiedade), liga a técnica ao objetivo (exercício) e devolve o controlo ao utente.

NMES — ajudar o músculo a trabalhar

«Depois de uma lesão ou de uma cirurgia, o músculo fica um pouco 'desligado' e custa ativá-lo sozinho. Este aparelho ajuda: faz o músculo contrair durante alguns segundos e depois descansar. Vai sentir o músculo a apertar com bastante força — é normal e é isso que queremos. O seu papel é contrair ao mesmo tempo que o aparelho. Assim ensinamos o músculo a voltar a trabalhar mais depressa. Se ficar desconfortável, paramos ou baixamos.»

Porque funciona: normaliza a sensação de contração forte (que assusta quem não está à espera) e transforma o utente em participante ativo.

FRASE DE FECHO (SERVE PARA TODAS AS CORRENTES)

«Isto é uma ajuda para o tratamento, não o tratamento todo. O que faz mais diferença é o que vamos fazer a seguir e o que vai fazer em casa.»

© Todos os direitos reservados

Explicar a eletroterapia em 30 segundos (2/2)

FES — estimulação durante a marcha

«Vamos usar a estimulação enquanto anda. Quando levantar o pé para dar o passo, o aparelho envia um impulso ao nervo que levanta a ponta do pé, para não tropeçar. Vai sentir um formigueiro abaixo do joelho e o pé a subir quase sozinho. Começamos devagar, comigo sempre ao seu lado, e vamos aumentando a distância à medida que se sentir seguro/a.»

Porque funciona: em utentes neurológicos o medo de cair é dominante — a fala põe a segurança em primeiro lugar.

Interferencial — alívio de dor em zonas articulares

«Vamos usar duas correntes muito fracas que se cruzam dentro da articulação, por isso coloco quatro elétrodos em cruz. Vai sentir um formigueiro mais profundo e, para a maioria das pessoas, agradável. Serve para aliviar a dor. Precisa de ficar quieto/a durante 15 a 20 minutos; se a sensação mudar ou incomodar, avise-me.»

Porque funciona: explica os quatro elétrodos (que geram perguntas) e a necessidade de imobilidade.

Regras de linguagem

Evitar	«choque», «descarga», «vai doer um bocadinho», «máquina milagrosa», «isto cura»
Preferir	«impulsos», «formigueiro», «contração», «ajuda», «complemento», «vamos medir se resulta»
Confirmar	No fim, pedir ao utente que explique por palavras suas o que vai sentir e o que deve fazer se incomodar.
Controlo	Dizer sempre que pode pedir para baixar ou parar — e cumprir de imediato.

© Todos os direitos reservados

Medos e objeções: respostas prontas (1/2)

Utente: «Vai dar choque?»

Resposta: «Não no sentido que está a imaginar. É uma corrente muito fraca, controlada por mim, e começo do zero, a subir devagar. O que vai sentir é um formigueiro. Se não gostar da sensação, baixamos ou paramos.»

Nota para o fisioterapeuta: nunca começar com a intensidade da sessão anterior sem voltar a subir gradualmente.

Utente: «Dói?»

Resposta: «Não deve doer. A intensidade é ajustada pela sua sensação, não por um número. Formigueiro forte, sim; dor, ardor ou picada, não — e se acontecer, avisa-me e eu corrijo logo.»

Nota para o fisioterapeuta: ardor localizado num ponto do elétrodo pode indicar mau contacto: parar, verificar gel/elétrodo e pele.

Utente: «Tenho pacemaker.»

Resposta: «Obrigado por me dizer, é mesmo importante. Com pacemaker não faço estimulação elétrica. Temos outras técnicas igualmente úteis para o seu caso e vamos usá-las.»

Nota para o fisioterapeuta: pacemaker/CDI = contraindicação (Bónus 2). Registar na ficha e na triagem do consentimento.

Utente: «Estou grávida (ou posso estar).»

Resposta: «Obrigado por partilhar. Na gravidez não aplico correntes na barriga, na zona lombar nem na bacia. Para outras zonas, prefiro decidir consigo e, se for preciso, falar com o seu médico. Há muito que podemos fazer sem corrente.»

Nota para o fisioterapeuta: contraindicação estrita em abdómen, lombar e pélvis (Bónus 2). Em dúvida, não aplicar.

Utente: «Já fiz isso noutro sítio e não resultou.»

Resposta: «Faz sentido estar desconfiado/a. Aqui a corrente é só uma parte: usamo-la para conseguir fazer o exercício com menos dor. E vamos medir — se em três ou quatro sessões não houver melhoria, retiramos.»

Nota para o fisioterapeuta: definir um indicador mensurável na 1.ª sessão (dor ao movimento, tarefa funcional) e reavaliar.

© Todos os direitos reservados

Medos e objeções: respostas prontas (2/2)

Utente: «Isto não é só para passar o tempo?»

Resposta: «Pergunta justa. Cada técnica que uso tem um objetivo: hoje é baixar a dor para conseguirmos fazer o exercício que realmente muda o seu problema. Se não servir esse objetivo, não a uso.»

Nota para o fisioterapeuta: a melhor resposta a esta objeção é coerência: não deixar o utente sozinho 30 minutos ligado ao aparelho.

Utente: «Comprei um aparelho na internet. Posso usar em casa?»

Resposta: «Pode ser uma boa ajuda. Traga-o na próxima sessão: vejo se é adequado, ensino-lhe onde colocar os elétrodos, que programa usar e onde nunca os deve pôr.»

Nota para o fisioterapeuta: entregar parâmetros por escrito; reforçar: nunca no pescoço anterior, no peito ou sobre pele lesada.

Utente: «Fiquei com a pele vermelha.»

Resposta: «Uma vermelhidão ligeira por baixo dos elétrodos, que desaparece numa hora, é comum. Se tiver ardor, bolhas, comichão intensa ou se a vermelhidão durar mais do que isso, diga-me para eu ver.»

Nota para o fisioterapeuta: inspecionar, registar, ajustar intensidade/tempo e considerar alergia ao adesivo ou ao gel.

Utente: «Tenho medo de ficar dependente da máquina.»

Resposta: «Ainda bem que pensa nisso — eu também não quero. O plano é usar a corrente no início e ir retirando à medida que o exercício e a sua confiança aumentam. O objetivo é ficar bem sem precisar de mim.»

Nota para o fisioterapeuta: explicitar o critério de retirada; reforça a autoeficácia e a confiança no plano.

PRINCÍPIO GERAL

Validar a preocupação → explicar em linguagem simples → devolver o controlo ao utente → propor alternativa quando a eletroterapia não é adequada. Uma objeção bem respondida aumenta a confiança no profissional.

© Todos os direitos reservados

Consentimento Informado para Eletroterapia

Modelo orientativo · campos preenchíveis no PDF ou à mão

1. IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE

Nome completo: _____

Data de nascimento: _____ **N.º processo / utente:** _____

Contacto telefónico: _____ **Representante legal (se aplicável):** _____

2. FISIOTERAPEUTA RESPONSÁVEL

Nome: _____ **N.º cédula profissional:** _____

Gabinete / instituição: _____

3. TÉCNICA PROPOSTA

☐ TENS ☐ NMES ☐ FES ☐ Interferencial ☐ **Outra:** _____

Região a tratar: _____ **N.º previsto de sessões:** _____

Objetivo terapêutico: _____

4. TRIAGEM DE SEGURANÇA (preenchida com o fisioterapeuta)

Tem pacemaker, CDI ou outro dispositivo eletrónico implantado?	☐ Sim	☐ Não
Está grávida ou existe possibilidade de estar?	☐ Sim	☐ Não
Tem epilepsia ou já teve convulsões?	☐ Sim	☐ Não
Tem doença cardíaca ou arritmia diagnosticada?	☐ Sim	☐ Não
Tem ou teve cancro na zona a tratar?	☐ Sim	☐ Não
Tem ou teve trombose venosa / flebite na zona a tratar?	☐ Sim	☐ Não
Tem zonas com menos sensibilidade (ex.: diabetes, lesão nervosa)?	☐ Sim	☐ Não
Tem feridas, lesões ou irritação de pele na zona a tratar?	☐ Sim	☐ Não
Tem implantes metálicos (placas, parafusos, próteses) na zona?	☐ Sim	☐ Não
Tem alergia a adesivos, gel ou borracha?	☐ Sim	☐ Não

Observações: _____

© Todos os direitos reservados

5. Informação prestada ao utente

O que é	Aplicação de impulsos elétricos de baixa intensidade através de elétrodos colocados na pele, para alívio da dor, ativação muscular ou apoio à função, conforme a técnica indicada acima.
Benefícios esperados	Variam de pessoa para pessoa e não podem ser garantidos. A eletroterapia é usada como complemento ao exercício e às restantes intervenções do plano de fisioterapia.
Riscos possíveis	Vermelhidão transitória da pele; desconforto durante a aplicação; cansaço muscular; raramente, irritação cutânea, reação ao adesivo/gel ou queimadura cutânea.
Alternativas	Outras intervenções de fisioterapia sem corrente elétrica (exercício, terapia manual, educação, outras modalidades), que foram explicadas ao utente.
Direitos do utente	Pode colocar questões, recusar ou retirar este consentimento a qualquer momento, sem prejuízo para a continuidade dos cuidados.

6. Declarações do utente

- ☐ Fui informado/a, em linguagem que compreendi, sobre a natureza, o objetivo, os benefícios esperados, os riscos e as alternativas da técnica proposta.
- ☐ Respondi com verdade às perguntas da triagem de segurança e comprometo-me a informar o fisioterapeuta de qualquer alteração (ex.: gravidez, novo dispositivo implantado, nova medicação).
- ☐ Compreendo que devo avisar de imediato se sentir dor, ardor, picada, calor excessivo, tonturas ou mal-estar.
- ☐ Tive oportunidade de fazer perguntas e todas foram esclarecidas.
- ☐ Sei que posso retirar este consentimento a qualquer momento.

Nestas condições, autorizo a aplicação da técnica de eletroterapia descrita.

Assinatura do utente / representante: _____

Assinatura do fisioterapeuta: _____ **Data:** _____

7. Revogação (preencher só se aplicável)

Declaro que retiro o consentimento acima prestado.

Assinatura: _____ **Data:** _____

Modelo orientativo ElectroMapas. Adaptar às normas da instituição e à legislação em vigor. Guardar o original no processo clínico do utente. Não constitui aconselhamento jurídico.

© Todos os direitos reservados

O que vai sentir na sessão de eletroterapia

Informação para o utente. Leia com calma e pergunte ao seu fisioterapeuta tudo o que não for claro.

ANTES DA SESSÃO

• Venha com roupa confortável que permita expor a zona a tratar.
• No dia da sessão, não aplique cremes, óleos ou loções na zona.
• Informe sempre o fisioterapeuta se tem pacemaker ou outro aparelho implantado, se está ou pode estar grávida, se tem epilepsia, problemas de coração, feridas na pele ou zonas com menos sensibilidade.

DURANTE A SESSÃO

• Vai sentir um formigueiro, que pode ser suave ou forte. Em alguns tratamentos, vai também sentir o músculo a contrair sozinho durante uns segundos — é normal.
• A intensidade é ajustada à sua sensação. Pode pedir para baixar ou parar a qualquer momento.
• A sensação deve ser forte mas confortável. Não deve doer, arder nem picar.
• Não mexa no aparelho nem nos elétrodos sem indicação.

AVISE DE IMEDIATO SE SENTIR

Ardor, picada ou dor num ponto, calor excessivo, tonturas, mal-estar, palpitações ou qualquer sensação estranha.

DEPOIS DA SESSÃO

• É comum ficar uma ligeira vermelhidão onde estavam os elétrodos; costuma desaparecer em menos de uma hora.
• O alívio da dor pode durar algumas horas. Aproveite para fazer os exercícios que lhe foram indicados.
• Depois de estimulação muscular, pode sentir o músculo cansado, como após exercício.
• Se a pele ficar com bolhas, comichão intensa ou vermelhidão persistente, contacte o gabinete.

Próxima sessão — dia: _____ **Hora:** _____ **Contacto:** _____

Fisioterapeuta: _____

© Todos os direitos reservados

O meu plano de exercícios em casa

Nome: _____ **Data de início:** _____

Fisioterapeuta: _____ **Contacto:** _____

Exercício	Como fazer	Séries × rep. / tempo	Vezes por dia
Contração do quadríceps (sentado/deitado)	Joelho esticado, apertar a coxa e empurrar a parte de trás do joelho contra a cama. Manter e relaxar.	10 × 5 s	2–3
Ponte	Deitado de costas, joelhos dobrados. Subir a bacia sem arquear a lombar, descer devagar.	2 × 10	1
Rotação do pescoço	Sentado, costas direitas. Rodar a cabeça devagar para cada lado até ao limite confortável.	2 × 8 cada lado	2
Elevação dos calcanhares	De pé, apoiado numa superfície estável. Subir na ponta dos pés e descer devagar.	2 × 12	1

Os 4 exercícios acima são exemplos genéricos. O fisioterapeuta risca os que não se aplicam e escreve os exercícios do seu plano nas linhas em branco.

REGRA DO SEMÁFORO PARA A DOR (0 = sem dor · 10 = pior dor imaginável)

VERDE (0–3): pode continuar. AMARELO (4–5): reduza repetições ou amplitude. VERMELHO (> 5, ou dor que não volta ao habitual até à manhã seguinte): pare esse exercício e fale com o fisioterapeuta.

Registo semanal — marque ✓ nos dias em que fez o plano

Semana	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
1.ª	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.ª	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.ª	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

© Todos os direitos reservados

10 mensagens para WhatsApp / SMS (1/2)

Substitui o texto entre [ ] antes de enviar. Envia apenas a utentes que deram consentimento para serem contactados por este meio (ver pág. 13).

01 · Confirmação de marcação (24 h antes)

Olá, [nome]. Daqui fala [fisioterapeuta], do [gabinete]. Lembramos a sua sessão de fisioterapia amanhã, [data], às [hora]. Para confirmar, responda SIM. Se precisar de remarcar, responda REMARCAR. Até amanhã!

Finalidade: gestão de marcações (contacto necessário à prestação do serviço).

02 · Preparação para a primeira sessão

Olá, [nome]. Para a sessão de [data]: traga roupa confortável que permita expor a zona a tratar, evite cremes ou óleos na pele nesse dia e traga exames ou relatórios que tenha. Qualquer dúvida, estamos por aqui.

Finalidade: gestão de marcações. Não incluir diagnósticos nem dados clínicos na mensagem.

03 · Depois da primeira sessão (24–48 h)

Olá, [nome]. Como se sentiu depois da sessão de ontem? Uma ligeira sensibilidade na zona tratada é normal nas primeiras horas. Se notar algo fora do habitual, responda a esta mensagem ou ligue para [telefone].

Finalidade: acompanhamento do tratamento. Se o utente responder com dados clínicos, transferir para o registo clínico e responder por telefone/consulta.

04 · Lembrete do plano domiciliário (semana 1)

Olá, [nome]. Passou uma semana desde que começámos. Está a conseguir fazer os exercícios em casa? Se algum lhe estiver a custar ou a provocar dor, diga-nos — ajustamos na próxima sessão.

Finalidade: acompanhamento do tratamento. Enviar apenas a quem aceitou receber lembretes.

05 · Falta à sessão (sem julgamento)

Olá, [nome]. Hoje sentimos a sua falta na sessão das [hora]. Está tudo bem? Quando quiser, responda com o melhor dia e horário e encontramos uma nova vaga.

Finalidade: gestão de marcações. Tom neutro: nunca referir custos de falta nesta mensagem.

© Todos os direitos reservados

10 mensagens para WhatsApp / SMS (2/2)

06 · Reagendamento após cancelamento

Olá, [nome]. Recebemos o seu cancelamento, obrigado por avisar. Para não interromper o plano, temos vagas em [dia/hora 1] ou [dia/hora 2]. Qual prefere?

Finalidade: gestão de marcações.

07 · Fim do plano / alta

Olá, [nome]. Foi um gosto acompanhá-lo/a. Lembre-se: os exercícios de manutenção que combinámos são o que protege os resultados. Se os sintomas voltarem, fale connosco antes de piorarem.

Finalidade: acompanhamento do tratamento (encerramento do episódio).

08 · Reativação (30 dias sem marcação)

Olá, [nome]. Como tem estado [o joelho / as costas / a zona tratada]? Se precisar de uma consulta de revisão, temos disponibilidade esta semana. Para deixar de receber mensagens, responda SAIR.

Mensagem de reativação: enviar SÓ com consentimento específico para contactos de acompanhamento/divulgação. Incluir sempre a opção SAIR.

09 · Check-in (90 dias após a alta)

Olá, [nome]. Passaram três meses desde a sua alta. Está a conseguir manter a atividade que tinha como objetivo? Se quiser, marcamos uma revisão curta. Para deixar de receber mensagens, responda SAIR.

Mensagem de reativação: requer consentimento específico registado. Respeitar de imediato pedidos de oposição.

10 · Pedido de avaliação no Google (após alta, utente satisfeito)

Olá, [nome]. Obrigado pela confiança durante o tratamento. Se achar justo, a sua opinião sincera no Google ajuda outras pessoas a encontrar o gabinete: [link]. Não é obrigatório — e agradecemos de qualquer forma.

Enviar uma única vez, sem insistência e sem qualquer contrapartida. Ver página 14.

© Todos os direitos reservados

RGPD na prática: mensagens ao utente

- Separar finalidades: mensagens de marcação e de acompanhamento do tratamento são diferentes de mensagens de reativação ou divulgação. Para estas últimas, recolher consentimento específico, livre e registado.
- Registar quando, como e para quê o utente consentiu — e permitir retirar o consentimento tão facilmente como o deu (ex.: responder SAIR). Cumprir o pedido de imediato e anotar a data.
- Mínimo de dados: não enviar diagnósticos, resultados de exames ou detalhes clínicos por WhatsApp/SMS. Se o utente os enviar, responder por telefone ou em consulta e registar no processo clínico.
- Usar um número/conta profissional do gabinete, com acesso restrito, e não partilhar contactos de utentes em grupos ou listas visíveis (usar envio individual).
- Respeitar horários razoáveis (ex.: dias úteis, 9h–19h) e uma frequência baixa: nenhuma mensagem de reativação mais do que uma vez por mês.
- Informar o utente sobre quem trata os dados, para quê, por quanto tempo e como exercer os seus direitos (acesso, retificação, apagamento, oposição) — normalmente na política de privacidade do gabinete.

Registo de consentimentos de contacto

Utente	Data	Canal	Marcações / acompanh.	Reativação / divulg.	Retirado em

Nas colunas de finalidade, escrever «Sim» / «Não». Guardar este registo junto do processo ou no software de gestão do gabinete. Modelo orientativo — não constitui aconselhamento jurídico.

© Todos os direitos reservados

Guião para pedir avaliações no Google

Quando pedir

- No fim do plano (alta) ou quando o utente refere espontaneamente uma melhoria clara.
- Pessoalmente, no fim da sessão, e só depois por mensagem (mensagem 10), com o link direto.
- Uma vez por utente. Sem insistência.

Fala para pedir em consulta (≈20 segundos)

«Fico muito contente por ver que já consegue [objetivo atingido]. Uma pergunta: se achar justo, importava-se de deixar a sua opinião sincera no Google? Ajuda outras pessoas com o mesmo problema a encontrar-nos. Posso enviar-lhe o link por mensagem? Não é obrigatório, claro.»

Pedir uma opinião sincera — nunca uma avaliação «de 5 estrelas».

O QUE NUNCA FAZER

- Oferecer descontos, sessões grátis ou brindes em troca de avaliações (violação das políticas do Google).
- Pedir avaliações só a quem está satisfeito através de filtros ou inquéritos prévios.
- Escrever avaliações em nome do utente, de familiares ou da equipa.
- Confirmar, numa resposta pública, que a pessoa é utente ou referir qualquer dado clínico.

Como responder (sem quebrar o sigilo profissional)

Avaliação positiva	«Muito obrigado pelas suas palavras. É um gosto ver quem nos procura voltar a fazer o que gosta. Votos de boa continuação! — Equipa [gabinete]»
Avaliação negativa	«Lamentamos a experiência que descreve. Levamos todas as opiniões a sério. Por respeito à privacidade, não comentamos situações individuais em público — pedimos que nos contacte através de [telefone/email] para conversarmos. — Direção [gabinete]»
Avaliação sem texto	«Obrigado pela sua avaliação. — Equipa [gabinete]»

Regra de ouro: responder em 48–72 h, com calma, sem detalhes clínicos e sem discutir em público. Verifica também as regras aplicáveis à publicidade em saúde e o código deontológico da tua profissão.

© Todos os direitos reservados

Checklist da primeira consulta

Antes do utente chegar

- [ ] Marcação confirmada (mensagem 01) e indicações de preparação enviadas (mensagem 02).
- [ ] Ficha clínica, consentimento informado e folheto impressos ou prontos no tablet.
- [ ] Equipamento testado, elétrodos em bom estado, gel e material de higiene da pele disponíveis.

Acolhimento e anamnese

- [ ] Apresentar-se, explicar a duração e a estrutura da consulta.
- [ ] Motivo da consulta, história, medicação, expectativas e objetivo do utente (nas palavras dele).
- [ ] Rastreio de sinais de alerta e triagem de contraindicações à eletroterapia (Bónus 2).

Avaliação e decisão partilhada

- [ ] Avaliação física e definição de 1–2 indicadores mensuráveis para reavaliar.
- [ ] Explicar o raciocínio e o plano; usar a fala de 30 segundos da técnica escolhida.
- [ ] Responder a medos e objeções; consentimento informado preenchido e assinado.

Primeira aplicação

- [ ] Teste de sensibilidade e inspeção da pele antes de colocar os elétrodos.
- [ ] Subir a intensidade gradualmente, guiada pela sensação; confirmar conforto aos 2–3 minutos.
- [ ] Inspecionar a pele no fim e registar parâmetros e resposta (Ficha de Evolução — Bónus 4).

Fecho e continuidade

- [ ] Entregar o folheto «O que vai sentir na sessão» e o plano domiciliário, explicando a regra do semáforo.
- [ ] Marcar a próxima sessão antes de o utente sair.
- [ ] Registar os consentimentos de contacto (pág. 13) e agendar a mensagem 03 para 24–48 h.

© Todos os direitos reservados